

26. 実践：肺

所要時間：05:35

学習シート

コース概要

このビデオは、肺の生体力学的アプローチに焦点を当て、肺の揺動運動と胚性支点の探索が、肺の主要な機能を回復させるためにいかに不可欠であるかを強調しています。参加者は、肺、胸膜、および周囲の組織間のダイナミクス、特に悲しみなどの感情がどのように肺に宿り、呼吸に影響を与えるかを観察する方法を学びます。組織間の対話を開始し、滲出液で混雑した胸膜腔を解放するためのテクニックも議論され、呼吸器の健康を改善するための肺の構造的および感情的な再編成の重要性が強調されています。

肺のプラクティス

後方の手は前方の手よりもわずかに低く、前方の手はわずかに高い位置にあります。これは、肺がその軸上で揺動する動きによるものです。この動きは、肺の**胚性フィールド**に入り込み、**胚性支点**を探すために不可欠です。この支点は吸引の場を表し、肺の主要な機能、つまり**生命の息吹を受け入れる準備を整える**という点で、自己を再活性化することを可能にします。

胚発生 of 9ヶ月間、肺はこの最初の動きのために準備されます。肺は**羊水**を生成します。これは、胚が生存のために必要とするため、極めて重要な機能です。この液体は、腎臓の尿の一部から作られます。後に、**サーファクタント**と呼ばれる**特定のタンパク質**が生成され、出生時に肺が開くことを可能にします。

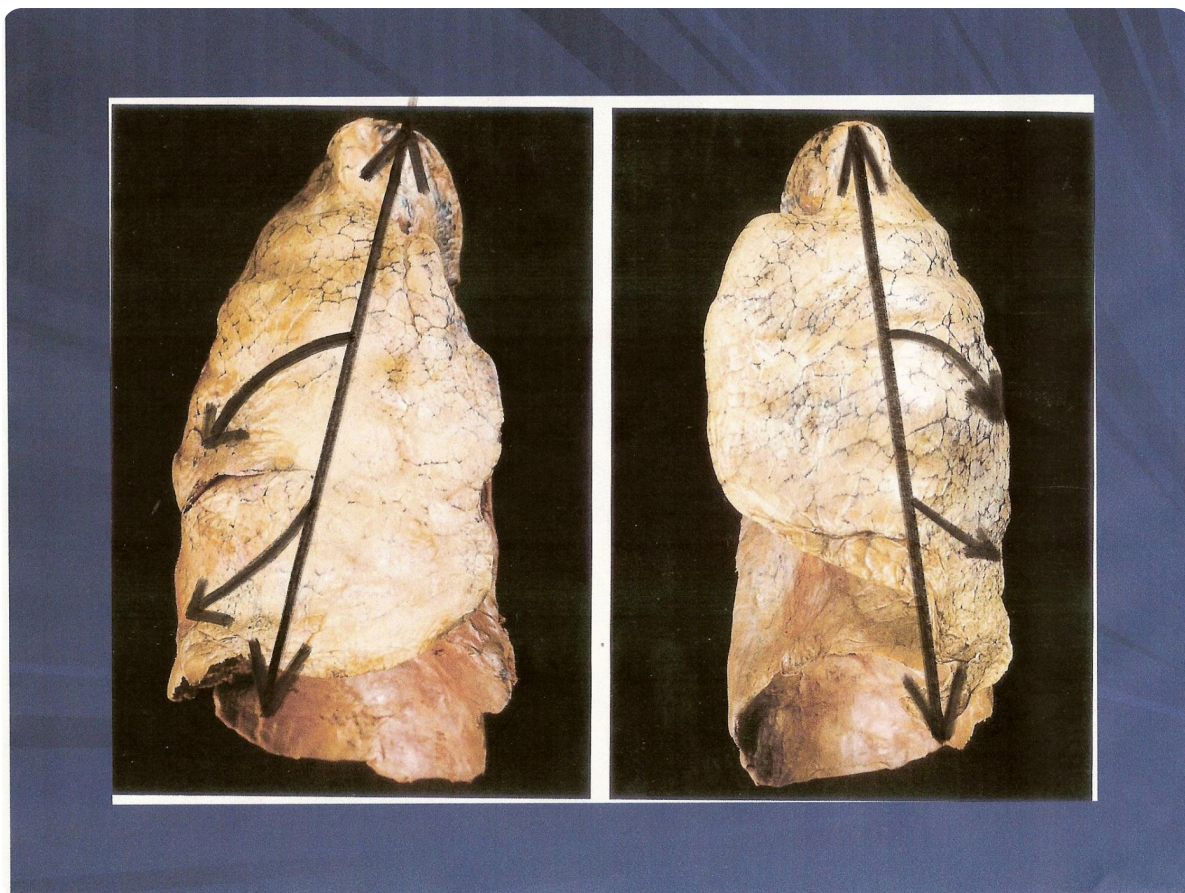
最初は、加えられる圧力は穏やかです。これは、肺が組織化され、その自由を取り戻すことができる空間を徐々に見つけることです。**臓側胸膜**と**壁側胸膜**の間には、気管、気管支、および空気と残気量を含む気管支組織、ならびに液体空間との出会いがあります。

この組織は、内面化された**悲しみ**のような感情を宿す可能性があることに注意することが重要です。例えば、肺で泣く子供や気管支炎に苦しむ子供は、言葉にできない悲しみを表現している可能性があります。この組織に優しく働きかけることで、対話と**組織の酸化交換**を開始することが可能です。

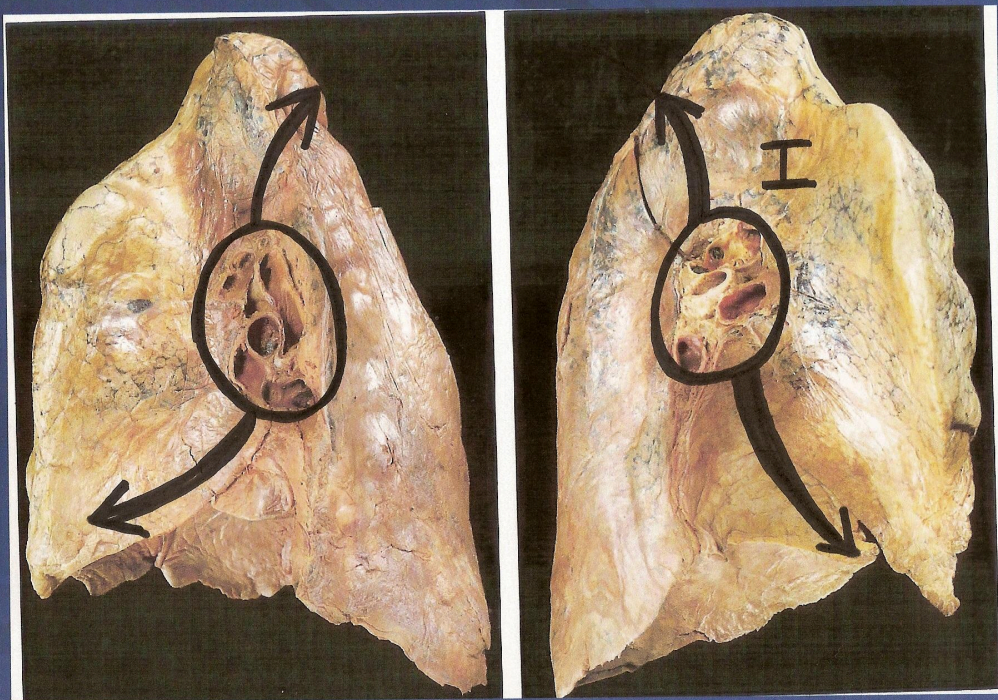
大後裂を通して、隠された感情のある空間にアクセスすることができます。体が動き、再編成の軸に集中することが不可欠です。**肋骨胸膜肺陥凹**は、肺の老廃物が沈着する滲出液の蓄積袋です。これらの領域は、しばしば可動性が低く、活性化され解放される必要があります。

また、肺をその付着点、特に**胸膜ドームの懸垂靱帯**から解放することも重要です。**肋骨横隔膜陥凹**や**横隔膜縦隔陥凹**のような陥凹は、縦隔と心臓の自由において重要な役割を果たします。

羊水の生成は妊娠**5週目**から始まり、**38週目**まで発達し、サーファクタントは**25週目**頃に出現します。気管支炎や細気管支炎などの肺疾患は、胚性段階で表現されなかった問題が**液体**の形で現れることで解決しようとする兆候である可能性があります。私たちは「肺で泣いている」と言うことができます。



図一 上斜め葉



図一 嚢胞性肺疾患